# MỤC LỤC

**MỤC LỤC i**

## DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| | |
|---|---|
| BS | Bác sỹ |
| BVC | Bệnh viện C |
| CĐ | Cao đẳng |
| CSSK | Chăm sóc sức khỏe |
| ĐH | Đại học |
| ĐD | Điều dưỡng |
| NB | Người bệnh |
| TH | Tổng hợp |
| THCS | Trung học cơ sở |
| THCN | Trung học chuyên nghiệp |
| PTTH | Phổ thông trung học |
| PTCS | Phổ thông cơ sở |
| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Thông tin của ĐTNC……....11
Bảng 3.2 Nhận xét của người bệnh về sự tiếp đón của ĐD lúc vào viện……12
Bảng 3.3 Nhận xét của NB về các CS hỗ trợ về tinh thần của ĐD……....12
Bảng 3.4 Nhận xét của NB về TH các kỹ năng chuyên môn của ĐD……..…13
Bảng 3.5 Nhận xét của NB về giải thích các hoạt động CS của ĐD……..14
Bảng 3.6 Hài lòng về cung cấp các thông tin và giáo dục sức khỏe cho NB..14
Bảng 3.7 Nhận xét của người bệnh với công tác vệ sinh khoa phòng…….....15
Bảng 3.8 Nhận xét của NB về tinh thần, thái độ phục vụ của điều dưỡng….15
Bảng 3.9 Đánh giá chung về chế độ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng…16

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong công quá trình điều trị người bệnh ngoài việc chẩn đoán, điều trị, một vấn đề quan trọng đó là công tác chăm sóc người bệnh của đội ngũ điều dưỡng. Thực tế cho thấy đội ngũ ĐD chiếm hơn một nửa nguồn nhân lực cán bộ y tế tại bệnh viện.

Công tác CSNB là thiết yếu đối với tất cả các khoa lâm sàng trong bệnh viện, công tác chăm sóc diễn ra thường xuyên liên tục 24/24 giờ. Nếu được chăm sóc tốt NB sẽ giảm thời gian, giảm được chi phí điều trị, sớm được trở lại với gia đình và cộng đồng. Đồng thời chất lượng điều trị được nâng cao, tạo uy tín cho tập thể đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện và sự hài lòng của NB và người nhà người bệnh.

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh (CSNB) và thực hiện tốt Quy chế CSNB theo Thông tư số 07/BYT ngày 26/11/2011 của Bộ Y tế thì các bệnh viện cần phải có đội ngũ ĐD chính quy; Thành thạo kỹ năng chuyên môn, thực hành và kỹ năng giao tiếp tốt.

Đảm bảo an toàn trong công tác CSNB là một trong những tiêu chí phấn đấu của khoa Y học cổ truyền nói riêng và Bệnh viện C nói chung . Đây là một công việc cần phải cải tiến liên tục với mục đích ngày càng hoàn thiện hơn.

Bệnh viện C nói chung và khoa Y học cổ truyền nói riêng trong nhiều năm qua đã tạo được niềm tin, sự uy tín của người bệnh đến khám và nằm điều trị. Vì thế chúng tôi luôn xác định công tác điều dưỡng giữ một vị trí rất quan trọng. Hiện tại công tác điều dưỡng tại khoa Y học cổ truyền đã có nhiều tiến bộ trong CSNB. Nhưng so với yêu cầu thực tế thì công tác chăm sóc của điều dưỡng vẫn còn một số tồn tại; tính chủ động của ĐDV chưa cao, còn phụ thuộc vào y lệnh điều trị của bác sĩ, công tác chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện và kỹ năng giao tiếp vẫn còn hạn chế. Tất cả những tồn tại đó đều ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.

- Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài:

"**Nhận xét công tác chăm sóc người bệnh đang điều trị nội trú tại khoa Y học Cổ truyền của Điều dưỡng Bệnh viện C, Thái Nguyên, năm 2017"** Với 2 mục tiêu

1. Mô tả thực trạng công tác chăm sóc người bệnh đang điều trị nội trú tại khoa Y học cổ truyền của điều dưỡng, Bệnh viện C

2. Đề xuất một số nguyên nhân, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại khoa Y học cổ truyền

# CHƯƠNG I
# TỔNG QUAN

## 1.1. Các khái niệm

### 1.1. 1. Khái niệm về chăm sóc điều dưỡng:

Chăm sóc điều dưỡng là những chăm sóc chuyên môn của người điều dưỡng đối với người bệnh từ khi vào viện đến lúc ra viện. Nội dung chính bao gồm: Châm sóc về thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc theo dõi, phục hồi chức năng, giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Chăm sóc điều dưỡng bắt đầu từ lúc người bệnh đến khám, vào viện và cho đến khi người bệnh ra viện hoặc tử vong. Công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện đảm bảo lấy người bệnh làm trung tâm, các hoạt động, dịch vụ chăm sóc, điều trị dựa trên đánh giá các nhu cầu của người bệnh và hướng tới người bệnh để phục vụ [5]

### 1.1.2. Vị trí của điều dưỡng viên

Trong các cơ sở y tế, người bệnh là đối tượng phục vụ của ĐDV. Do vậy ĐDV cần phải hiểu mỗi cá thể ở một phương diện nào đó giống tất cả mọi người, ở một phương diện khác chỉ giống một số người, có những phương diện không giống ai. Con người cũng có cá tính riêng biệt, có thể thay đổi khi bị tác động bởi các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tinh thần trong môi trường sống, làm việc và tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của mỗi con người đó. Phân loại của Maslow: rất hữu ích để làm nền tảng cho ĐDV thực hiện công việc nhận định tình trạng về bệnh tật của người bệnh, về những giới hạn và nhu cầu đòi hỏi sự can thiệp chăm sóc. Những nhu cầu này bao gồm: nhu cầu về thể chất và sinh lý; nhu cầu về an toàn và an ninh; nhu cầu về tình cảm và mối quan hệ; nhu cầu được tôn trọng; nhu cầu tự hoàn thiện.Theo Virginia Henderson thì thành phần của chăm sóc cơ bản bao gồm 14 yếu tố. ĐDV cần nhận biết nhu cầu người bệnh để có kế hoạch đáp ứng trong quá trình thực hiện CSNB, bao gồm đáp ứng nhu cầu về: hô hấp, ăn uống, giúp đỡ người bệnh về sự bài tiết, tư thế, vận động; …[6].

### 1.1.3. Vai trò chức năng của người điều dưỡng [2], [3]

Bác sỹ và Điều dưỡng là hai nghề có định hướng khác nhau: bác sỹ làm nhiệm vụ chẩn đoán và điều trị. Điều dưỡng chăm sóc và đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thể chất và tinh thần cho người bệnh. Để đảm bảo nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc, giúp người bệnh sớm bình phục sức khỏe thì đối tượng nào cũng phải hoàn thành tốt vai trò nghề nghiệp của mình đồng thời cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa Thầy thuốc và điều dưỡng. Vai trò chức năng chủ yếu của người điều dưỡng chủ yếu là:

1. Người chăm sóc
2. Người truyền đạt thông tin
3. Người tư vấn
4. Người biện hộ cho người bệnh

### 1.1.4.Vai trò của chăm sóc người bệnh (CSNB)

Nghề y là một nghề đặc biệt vì nó liên quan đến khám, chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi và nâng cao sức khỏe cho con người. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe là dịch vụ công cộng, liên quan tới vấn đề an sinh xã hội, tới mọi người, mọi nhà và cộng đồng [7]. Người khỏe mạnh tự đáp ứng được các nhu cầu của họ. Khi bị bệnh tật, ốm yếu, nhập viện nhiều, NB không tự đáp ứng được nhu cầu hàng ngày cho chính mình nên cần sự hỗ trợ của người ĐD và người thân. NB không chỉ có nhu cầu về chữa bệnh mà còn có nhu cầu về thể chất, tinh thần, xã hội và nhu cầu thiết lập mối quan hệ với BS và ĐD.

Jean Watson đưa ra hai giả định về giá trị của chăm sóc con người là: Chăm sóc và tình cảm tạo ra những năng lượng cơ bản về thể chất và tinh thần; Chăm sóc và tình cảm thiết yếu cho sự tồn tại và nuôi dưỡng con người [7].

Theo Virginia Henderson “Chăm sóc phải thỏa mãn các nhu cầu vật chất, tâm lý, văn hóa - xã hội và tinh thần của NB” [5]. Trên cơ sở này, Danielsson (1988) đã nêu “Chăm sóc phải được thực hiện một cách nỗ lực nhằm đáp ứng và

thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân, do vậy phải sử dụng các nguồn lực sẵn có để duy trì hoặc phục hồi tình trạng sức khỏe tốt nhất hoặc là để thỏa mãn nhu cầu của NB" [8].

Để nhận biết được những nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân NB, NVYT cần được trang bị đủ kiến thức, cơ sở lý luận của các học thuyết về nhu cầu của mỗi cá nhân, chăm sóc ĐD và CSNB toàn diện.

### 1.1.5. Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Năm 2000, WHO đã nêu khái niệm "sự thông cảm" nhằm cố gắng đưa ra đặc điểm sự hài lòng của người dân trong hệ thống y tế. Sự thông cảm được định nghĩa là "đo lường những hoạt động của hệ thống không liên quan đến gía trị về y tế, kỳ vọng của người dân về cư xử của những người cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và những dịch vụ không liên quan đến con người" [7]. WHO đã nêu 7 đặc điểm của sự thông cảm và được liệt kê thành 2 nhóm:

*** Tôn trọng con người**

- Tôn trọng giá trị của con người
- Sự bí mật
- Tự chủ tham gia chọn lựa sức khỏe của chính mình

*** Định hướng khách hàng**:

- Quan tâm ngay đối với những trường hợp cấp cứu và thời gian chờ đợi hợp lý
- Đối với trường hợp không cấp cứu.
- Chất lượng đầy đủ như sạch sẽ, không gian rộng rãi
- Tiếp nhận được những hỗ trợ từ ngoài
- Tự do chọn lựa chọn (cá nhân hay tổ chức) cung cấp dịch vụ

Dựa trên những tiêu chí của viện Picker, WHO và những nghiên cứu về sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đã công bố trên y văn thế giới, có thể đưa ra các tiêu chí đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân theo 4 vấn đề sau:

* Sự hài lòng của NB khi tiếp cận dịch vụ: người bệnh được nhận các dịch vụ chấp nhận được như

- Về thời gian như : thời gian chờ đợi
- Về giá cả : phù hợp thu nhập
- Thủ tục thanh toán nhanh chóng

- Sự hài lòng của NB khi giao tiếp và tương tác với nhân viên y tế: NB được khám và điều trị, chăm sóc, thông tin và tư vấn với thái độ hòa nhã, thân thiện.
- Sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế; sự hài lòng của NB đối với cơ sở hạ tầng,trang thiết bị, y dụng cụ màNB được sử dụng.
- Sự hài lòng của người bệnh đối với kết quả khám, chữa bệnh : bệnh nhân hài lòng với kết quả về khám, phát hiện bệnh và điều trị bệnh

## 1.2. Những nghiên cứu trên Thế giới và Việt Nam về Công tác CSNB

Trên thế giới, theo Laurence Salomon, người bệnh ngày càng được nhận biết như một khía cạnh quan trọng của chất lượng chăm sóc sức khỏe

Nghiên cứu của Ivy F. Tso, sau khi phân tích các yếu tố chính (Factor analysis) và tính giá trị (validity) tác giả đã đưa ra 9 biến số được dùng để đánh giá công tác chăm sóc người bệnh bao gồm môi trường vật chất, trang thiết bị, sắp xếp lịch gặp, thời gian chờ đợi, dịch vụ ở phòng khám bệnh, bác sỹ khám bệnh, tính chuyên nghiệp của bác sỹ, sự giải thích của bác sỹ và thời gian tư vấn.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Trần Thị Hà Giang đánh giá công tác chăm sóc người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho thấy về giao tiếp của điều dưỡng là 43,85; hướng dẫn chế độ vệ sinh 66,75; hướng dẫn thủ tục hành chính cho NB 78,3%; . Các yếu tố liên quan tới sự hài lòng là tuổi, giới tính, trình độ học vấn [6]

Với đề tài đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định năm 2011, Nguyễn Thu cho thấy công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) được xác định

dựa vào 4 yếu tố: thời gian chờ đợi tiếp cận chăm sóc, tiếp cận và tương tác với nhân viên y tế bệnh viện, điều kiện cơ sở vật chất và kết quả nằm viện. Kết quả cho thấy tỷ lệ giao tiếp của điều dưỡng thân thiện với người bệnh 47,9%, tiếp đến là hướng dẫn nội quy 72,9%,  và CSSK là 85,4%. Tỷ lệ hài lòng với công tác vệ sinh và quang cảnh bệnh viện rất cao 98,3%, có tới 87,5% người bệnh sẵn sàng giới thiệu người khác đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên tỷ lệ hài lòng chung với dịch vụ CSSK tại bệnh viện thấp chỉ có 59,4% [9]

Nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn cho thấy công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình đội đạt kết quả cao trong chăm sóc, đặc biệt là hoạt động đi buồng vào buổi sáng. Người bệnh và người nhà người bệnh cũng được phát huy vai trò trong hoạt động chăm sóc dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng. Kết quả cũng cho thấy, các nhiệm vụ được điều dưỡng viên thường xuyên thực hiện cũng đạt khá cao 75,2%. Tuy nhiên còn một số nhiệm vụ mà điều dưỡng viên chưa thường xuyên thực hiện là: chăm sóc vệ sinh cá nhân cho Nb, chăm sóc phục hồi chức năng; giám sát người nhà hỗ trợ chăm sóc NB; tư vấn giáo dục sức khỏe cho NB [10]

Nghiên cứu đánh giá về công tác chăm sóc NB nội trú về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012 kết quả cho thấy:

- Tỷ lệ điều dưỡng cung cấp thông tin tại bệnh viện của khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu là 62,7%, khoa ngoại 31%, thấp nhất là nội nhi 25,4%
- Tỷ lệ Điều dưỡng giáo dục sức khỏe cho NB khi nằm viện khoa Sản 71,8%, khoa Ngoại 50,7%, khoa Nội Nhi 29,6%
- Tỷ lệ Điều dưỡng thực hiện công tác chăm sóc và điều trị đạt tốt: khoa khám Sản 94,4%, khoa Ngoại 70,4%, khoa Nội Nhi là 66,9% [8]

Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có nhiều những nghiên cứu đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng

# Chương 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 2.1. Đối tượng nghiên cứu

Bệnh nhân ≥ 18 tuổi đang điều trị nội trú tại khoa Y học cổ truyền

**Tiêu chuẩn chọn mẫu:**

- Người bệnh có thời gian nằm điều trị từ 3 ngày trở lên tại khoa YHCT
- NB có đủ năng lực để trả lời các câu hỏi và đồng ý tham gia vào NC

## 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.1. Thời gian: Từ tháng 01/9/2017 – 30/10/2017

2.2. Địa điểm: khoa Y học cổ truyền Bệnh viện C.

Khoa y học cổ truyền được thành lập từ 01/07/1994 với đội ngũ cán bộ gồm 01 bác sỹ chuyên khoa I, 01 thạc sỹ y học cổ truyền, 11 y sỹ y học cổ truyền. Hàng năm khoa tiếp nhận khoảng 400-500 người bệnh vào điều trị nội trú với các bệnh như đau lưng, đau dây TK tọa, đau vai gáy, thoát vị đĩa đệm, liệt dây thần kinh VII ngoại biên,…

## 2.3. Thiết kế nghiên cứu:

Nghiên cứu Mô tả cắt ngang

## 2.4. Xác định cỡ mẫu

- Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ ta có :

$$n=Z^2_{1-\alpha/2} * p(1-p)/d^2$$

- Trong đó

n: Số cỡ mẫu cần thiết

$Z_{(1-\alpha/2)}$: Hệ số với độ tin cậy 95% có giá trị là 1,96

P : tỷ lệ 80%

q : q = 1 – p= (1-0,8 )= 0,2

d : Sai số cho phép 10% (d = 0,1).

Thay các giá trị trên: n = 61

Như vậy sẽ có số đối tượng nghiên cứu là 61 người bệnh

**2.5 Phương pháp chọn mẫu:** Chọn mẫu ngẫu nhiên: mỗi ngày từ 1 đến 3 bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại khoa YHCT và chuẩn bị ra viện vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong thời gian từ 01/09/2017 đến 30/10/2017

**2.6. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu**

**2.6.1 Phương pháp thu thập số liệu**

* Quy trình thu thập số liệu: Mỗi người bệnh nằm điều trị nội trú tại khoa YHCT chuẩn bị ra viện được phát một phiếu phỏng vấn về công tác CSNB và trả lời những câu hỏi trong phiếu phỏng vấn để nhận xét đúng thực trạng CSNB của điều dưỡng trong khoa.

2.**6.2. Công cụ thu thập số liệu**

- Số liệu thu thập là các phiếu điều tra do các điều tra viên đã được tập huấn thống nhất phỏng vấn với bộ câu hỏi in sẵn (Phụ lục kèm theo)

**2.7. Phương pháp phân tích số liệu:**

- Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.

**2.8. Các chỉ số nghiên cứu**

**2.8.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu:** Tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn, giới tính, dân tộc

**2.8.2 Nhận xét của người bệnh về công tác CSNB của điều dưỡng**

- Nhận xét của người bệnh về sự tiếp đón của ĐD lúc vào viện
- Nhận xét của người bệnh về các CS hỗ trợ về tinh thần của ĐD
- Nhận xét của NB về thực hiện các kỹ năng chuyên môn của ĐD
- Nhận xét của NB về giải thích các hoạt động CS của ĐD
- Nhận xét của NB cung cấp các thông tin và giáo dục sức khỏe
- Nhận xét của người bệnh với công tác vệ sinh khoa phòng

- Nhận xét của NB về tinh thần, thái độ  phục vụ của điều dưỡng

- Đánh giá chung về chế độ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng

**2.9 Các tiêu chuẩn dùng trong nghiên cứu**

Tiêu chuẩn đánh giá công tác CSNB của ĐD được dựa trên :

- Thông tư số 07/2011 TT – BYT của Bộ Y tế, ngày 26/1/2011 về hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện [4]

- Bộ tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh trong các Bệnh viện của Hội Điều dưỡng Việt Nam [5]

**2.10. Đạo đức nghiên cứu**

- Đối tượng nghiên cứu phải được giải thích về mục đích và nội dung của nghiên cứu trước khi tiến hành điều tra và chỉ tiến hành khi có sự chấp nhận tham gia của đối tượng nghiên cứu.

- Mọi thông tin cá nhân của đối tượng nghiên cứu được giữ kín. Các số liệu, thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không phục vụ cho mục đích nào khác.

- Nghiên cứu cũng cần được sự chấp thuận của khoa YHCT. Kết quả nghiên cứu được phản hồi cho khoa và bệnh viện

**2.11.  Hạn chế của nghiên cứu, biện pháp và cách khắc phục:**

**2.11.1. Hạn chế của nghiên cứu**

- Thời gian của nghiên cứu còn ngắn, số đối tượng nghiên cứu còn ít, vì vậy kết quả nghiên cứu chưa đại diện được cho phạm vi toàn bộ cho bệnh viện.

- Nghiên cứu mới giới hạn trong phân tích định lượng chưa có phân tích định tính vì vậy kết quả còn hạn chế

**2.11.2. Biện pháp và Cách khắc phục:**

- Giải thích rõ với người bệnh về mục đích và nội dung của nghiên cứu

- Chọn điều tra viên có kinh nghiệm, tập huấn điều tra trước khi tiến hành thu thập số liệu tại cơ sở nghiên cứu.

- Những phiếu điều tra ban đầu sẽ được nhóm nghiên cứu giám sát hỗ trợ. Các phiếu điều tra được nhóm nghiên cứu kiểm tra cuối ngày khi nộp phiếu, với những thông tin thu thập được chưa đầy đủ hoặc không hợp lý sẽ được yêu cầu điều tra viên bổ sung.

# Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

## 3.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

**Bảng 3.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu**

| Thông tin chung | | Tần số (n) | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|
| **Tuổi** | ≤ 30 tuổi | 06 | 9.8 |
| | 31 – 50 tuổi | 11 | 18.0 |
| | ≥ 51 tuổi | 44 | 72.2 |
| **Giới** | Nam | 25 | 41.0 |
| | Nữ | 36 | 59.0 |
| **Dân tộc** | Kinh | 46 | 75.4 |
| | Khác | 15 | 24.6 |
| **Trình độ học vấn** | ≤ PTCS | 06 | 9.8 |
| | PTTH | 17 | 27.9 |
| | Trung học chuyên nghiệp | 26 | 42.6 |
| | Cao đẳng, ĐH và trên ĐH | 12 | 19.7 |
| **Nghề nghiệp** | Học sinh, sinh viên | 02 | 3.3 |
| | Nông dân | 09 | 14.8 |
| | Công nhân | 14 | 23.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cán bộ nhà nước | 12 | 19.7 |
| | Hưu trí | 24 | 39.2 |
| **Số lần đến điều trị tại khoa** | ≤ 1 lần | 19 | 31.1 |
| | ≥ 2 lần | 42 | 68.9 |

*** Nhận xét:** Bảng 3.1 cho thấy phần lớn ĐTNC ở độ tuổi ≥ 51 tuổi chiếm 72.2%, nữ (59%) cao hơn nam (41%), kết quả này thấp hơn với nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn năm 2011 cho kết quả 62,4% ĐTNC là giới nữ [10]. 2/3 đối tượng nghiên cứu là người dân tộc kinh 75,4% đó cũng là điều dễ hiểu bởi người dân sống ở vùng Thị Xã Sông Công chủ yếu là người dân tộc kinh; Hơn một nửa (62,3%) người bệnh có trình độ học vấn từ trung học chuyên nghiệp trở lên. Có tới (39.2%) ĐTNC nghề nghiệp hưu trí. Đa phần người bệnh đã vào điều trị lần 2 (68,9%)

### 3.2. Nhận xét của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng

**Bảng: 3.2. Nhận xét của người bệnh về sự tiếp đón của ĐD lúc vào viện**

| **Nội dung** | **Tốt** | | **Bình thường** | | **Chưa tốt** | | **Tổng** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **n** | **%** | **n** | **%** | **n** | **%** | **n** | **%** |
| Hướng dẫn các thủ tục hành chính khi NB vào khoa | 41 | 67.2 | 18 | 29.5 | 02 | 3.3 | 61 | 100 |
| Sự sắp xếp giường bệnh | 53 | 86.9 | 08 | 13.1 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn nội quy khoa phòng | 43 | 70.4 | 14 | 23.0 | 04 | 6.6 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn, hỗ trợ làm các XN | 59 | 96.7 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 61 | 100 |

*** Nhận xét**: Chăm sóc điều dưỡng là những chăm sóc chuyên môn của người điều dưỡng đối với NB từ khi vào viện đến lúc ra viện. Nội dung chính bao gồm: Châm sóc về thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc theo dõi, phục hồi chức năng, giáo dục sức khỏe cho NB. Công tác CSNB trong bệnh viện đảm bảo lấy NB làm trung tâm, các hoạt động, dịch vụ chăm sóc, điều trị dựa trên nhận xét của NB khi nằm viện, trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phần lớn Điều dưỡng tiếp đón người bệnh chu đáo lúc vào viện là tương đối cao, đặc biệt là điều dưỡng hướng dẫn và hỗ trợ làm các xét nghiệm chiếm 96.7%. Tuy nhiên vẫn còn 6.6% BN chưa được ĐD hướng dẫn nội quy khoa phòng và 3.3% chưa được hướng dẫn các thủ tục hành chính khi NB mới vào khoa, từ đây điều dưỡng trưởng cần tăng cường nhắc nhở điều dưỡng có ý thức giải thích thủ tục hành chính kỹ hơn nữa khi người bệnh vào viên.

**Bảng: 3.3. Nhận xét của NB về các CS hỗ trợ về tinh thần của ĐD**

| Nội dung | Tốt | | Bình thường | | Chưa tốt | | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sự quan tâm, thăm hỏi tình trạng sức khỏe của NB | 13 | 21.3 | 45 | 73.8 | 03 | 4.9 | 61 | 100 |
| Sự giúp đỡ của điều dưỡng khi NB cần | 51 | 83.6 | 10 | 16.3 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Sự động viên an ủi, khích lệ tinh thần NB | 18 | 29.5 | 43 | 70.5 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Tôn trọng sự riêng tư của NB trong CS | 55 | 90.2 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 61 | 100 |

*** Nhận xét:** bảng 3.3 cho kết quả phần lớn BN được điều dưỡng giúp đỡ khi người bệnh cần (83.6%). Có tới 90.2% Điều dưỡng tôn trọng riêng tư của người

bệnh. Tuy nhiên vẫn còn (4.9%) điều dưỡng chưa quan tâm thăm hỏi tình trạng sức khỏe của người bệnh. Điều này phòng Điều dưỡng phải thường xuyên kết hợp với các khoa lâm sàng tập huấn và kiểm tra, đánh giá hàng quý về công tác tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh đối với điều dưỡng

**Bảng: 3.4. Nhận xét của NB về thực hiện các kỹ năng chuyên môn của ĐD**

| Nội dung | Tốt | | Bình thường | | Chưa tốt | | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Kỹ năng thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc của điều dưỡng | 56 | 91.8 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn của ĐD về chế độ dùng thuốc | 59 | 96.7 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn chế độ ăn theo bệnh | 15 | 24.6 | 41 | 67.2 | 05 | 8.2 | 61 | 100 |
| Theo dõi diễn biến bệnh hàng ngày | 60 | 98.4 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Hỗ trợ động viên khuyến khích NB vận động để đề phòng biến chứng | 13 | 21.3 | 42 | 68.9 | 06 | 9.8 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn, hỗ trợ NB thực hiện vệ sinh cá nhân | 49 | 80.3 | 7 | 11.5 | 05 | 8.2 | 61 | 100 |

**Nhận xét:** Bảng 3.4 cho thấy điều dưỡng thực hiện kỹ năng chuyên môn của chiếm tỷ lệ rất cao như kỹ năng hướng dẫn sử dụng thuốc chiếm (96.7%), theo

dõi diễn biến bệnh hàng ngày chiếm (98.4%), hướng dẫn hỗ trợ thực hiện vệ sinh cá nhân (80.3%). Bên cạnh đó vẫn còn 9.8% BN chưa được điều dưỡng hỗ trợ động viên khuyến khích người bệnh vận động để đề phòng biến chứng và 8.2% chưa được điều dưỡng hướng dẫn chế độ ăn và vệ sinh cá nhân. Từ kết quả trên điều dưỡng viên cần phải thường xuyên hướng dẫn chế độ ăn và chế độ vệ sinh đối với người bệnh

**Bảng: 3.5 Nhận xét của NB về giải thích các hoạt động CS của ĐD**

| Nội dung | Tốt | | Bình thường | | Chưa tốt | | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Giải thích cho NB trước khi thực hiện mỗi quy trình kỹ thuật chăm sóc | 57 | 93.5 | 3 | 4.9 | 1 | 1.6 | 61 | 100 |
| Giải thích trước khi thực hiện thuốc, làm các XN cho NB | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100 |

*** Nhận xét**: Bảng 3.5 cho kết quả tỷ lệ điều dưỡng giải thích cho BN các hoạt động chăm sóc trước khi làm các thủ thuật và thực hiện thuốc, làm các xét nghiệm đều đạt 93.5% - 100 %, bên cạnh đó vẫn còn 1.6% điều dưỡng chưa giải thích cho NB trước khi thực hiện mỗi QTKT chăm sóc người bênh.

**Bảng: 3.6 Nhận xét của NB cung cấp các thông tin và giáo dục sức khỏe**

| Nội dung | Tốt | | Bình thường | | Chưa tốt | | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe cho NB | 52 | 85.2 | 0 | 0 | 9 | 14.8 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn NB cách tự chăm sóc khi nằm viện | 58 | 95.1 | 03 | 4.9 | 0 | 0 | 61 | 100 |
| Hướng dẫn NB cách | 56 | 91.8 | 05 | 8.2 | 0 | 0 | 61 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tự chăm sóc sức khỏe khi ra viện | | | | | | | | |

*** Nhận xét**: Bảng 3.6 cho thấy Đa phần điều dưỡng cung cấp các thông tin và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, cách tự chăm sóc sức khỏe khi ra viện chiếm 91.8%) , Cách tự chăm sóc khi nằm viện (95.1%). Tuy nhiên vẫn còn 14.8% BN chưa được điều dưỡng cung cấp thông itn về tình trạng sức khỏe cho người bệnh

**Bảng: 3.7 Nhận xét của người bệnh với công tác vệ sinh khoa phòng**

| Nội dung | Tốt | | Bình thường | | Chưa tốt | | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Vệ sinh phòng bệnh, hành lang, nhà vệ sinh | 21 | 34.4 | 33 | 54.1 | 07 | 11.5 | 61 | 100 |
| Vệ sinh các dụng cụ, phương tiện chăm sóc người bệnh | 56 | 91.8 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 61 | 100 |

*** Nhận xét:** Bảng 7 cho thấy tỷ lệ người bệnh đồng ý với công tác vệ sinh khoa phòng là sạch sẽ chiếm (34.4%), có tới 91.8% BN cho rằng các dụng cụ, phương tiện chăm sóc người bệnh được vệ sinh sạch sẽ bên cạnh đó vẫn còn 11.5% BN cho rằng về vệ sinh phòng bệnh hành lang, nhà vệ sinh còn bẩn chưa được tốt. Điều dưỡng trưởng cần tăng cường nhắc nhở và duy trì công tác tổng vệ sinh khoa phòng vào chiều trú 5 hàng tuần

**Bảng: 3.8. Nhận xét của NB về tinh thần, thái độ phục vụ của điều dưỡng**

| Nội dung | Tốt | | Bình thường | | Chưa tốt | | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Thái độ, giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận NB vào khoa | 37 | 60.7 | 24 | 39.3 | 0 | 0 | 61 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái độ, giao tiếp của điều dưỡng trong khi chăm sóc BN | 45 | 73.8 | 0 | 0 | 16 | 26.2 | 61 | 100 |
| Sự chuẩn bị, sắp xếp của ĐD khi người bệnh ra viện | 48 | 78.7 | 13 | 21.3 | 0 | 0 | 61 | 100 |

*** Nhận xét:** Phần lớn điều dưỡng phục vụ BN với tinh thần, thái độ, giao tiếp tận tình tốt đạt (60.7%), còn 26.2 % là ở mức chưa tốt, trong quá trình nằm điều trị bệnh người bệnh rất cần sự động viên, hỗ trợ của điều dưỡng điều này điều dưỡng cần phải tự giác chấp hành và nâng cao kỹ năng của bản thân

**Bảng 3.9: Đánh giá chung về chế độ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng**

| **Nội dung** | **Tốt** | | **Bình thường** | | **Chưa tốt** | | **Tổng** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **n** | **%** | **n** | **%** | **n** | **%** | **n** | **%** |
| Nhận xét chung của BN về chế độ chăm sóc của điều dưỡng trong thời gian nằm viện | 49 | 80.3 | 12 | 19.7 | 0 | 0 | 61 | 100 |

*** Nhận xét:** Bảng 3.9 cho thấy nói chung chế độ chăm sóc của điều dưỡng đối với BN tỷ lệ tốt đạt cao chiếm 80.3%, Tuy nhiên vẫn còn 19.7% BN cho rằng chế độ chăm sóc NB chỉ đạt mức bình thường

## 3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại khoa Y học cổ truyền

Qua nghiên cứu 61 người bệnh, chúng tôi đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện C như sau:

Khoa Y học cổ truyền cần bổ xung thêm một số trang thiết bị phục vụ cho Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh như đèn tần phổ…

Khoa cần phối hợp chặt chẽ với phòng Điều dưỡng đào tạo lại cho các điều dưỡng về các kỹ thuật chăm sóc NB để nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng

Củng cố công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo mô hình Đội tại khoa , từng điều dưỡng viên phải nắm chắc người bệnh và kịp thời xử trí khi NB có diễn biến và đáp ứng mọi nhu cầu của người bệnh.

Phối hợp với phòng Điều dưỡng trong việc phân công nhân lực điều dưỡng hàng ngày để đảm bảo nhân lực trong việc CSNB toàn diện

Hàng năm cần xây dựng và bổ xung Quy trình kỹ thuật, Quy trình chăm sóc người bệnh và tài liệu GDSK theo từng bệnh của khoa

Hàng năm lập kế hoạch tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử và đổi mới phong cách phục vụ người bệnh, nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghề điều dưỡng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng ngày về công tác CSNB

Hàng năm Mỗi điều dưỡng viên phải đưa ra một tiêu chí phấn đấu.

## KẾT LUẬN

### 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

- Tuổi : ĐTNC ở độ tuổi còn ≥ 51 tuổi chiếm 72.2%

- Giới: Nữ chiếm 59% cao hơn nam giới 41%

- Dân tộc: dân tộc kinh chiÕm khá cao 75,4%

- Trình độ học vấn:Trung học chuyên nghiệp trở lên chiếm (62.3%)

- Nghề nghiệp: Có (39.2%) ĐTNC nghề nghiệp đã nghỉ hưu

- Số lần khám: Người bệnh vào khoa điều trị lần 2 là (68,9%)

**2. Nhận xét của người bệnh về chế độ chăm sóc của điều dưỡng**

Qua nghiên cứu 61 người bệnh nằm điều trị nội trú tại khoa Y học cổ truyền thì kết quả cho thấy nhận xét của người bệnh về chế độ chăm sóc chung của điều dưỡng đạt rất cao (80.3%), tuy nhiên một số người bệnh cho rằng một số chế độ chăm sóc của điều dưỡng còn chưa thực hiện tốt đó là:

- Sự hướng dẫn nội quy khoa phòng 6.6%

- Sự hướng dẫn các thủ tục hành chính 3.3%

- Sự quan tâm thăm hỏi tình trạng sức khỏe của NB 4.9%

- Động viên an ủi, khích lệ tinh thần NB 9.8%

- Sự hướng dẫn chế độ ăn theo bệnh lý 8.2%

- Giải thích cho NB trước khi thực hiện mỗi QTCS 1.6%

- Sự cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe cho NB 14.8%

- Vệ sinh phòng bệnh, hành lang, nhà vệ sinh 11.5%

- Thái độ, giao tiếp của điều dưỡng trong khi chăm sóc BN 26.2%

## KHUYẾN NGHỊ

**1. Đối với khoa Y học cổ truyên**

- Khoa Y học cổ truyền cần bổ xung thêm một số trang thiết bị phục vụ cho Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh như đèn tần phổ…

- Khoa cần phối hợp chặt chẽ với phòng Điều dưỡng đào tạo lại  cho các điều dưỡng về các kỹ thuật chăm sóc NB để nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng

**2. Đối với điều dưỡng**

- Các điều dưỡng trong khoa cần phải tăng cường học tập và trao đổi những kinh nghiệm về kỹ năng chăm sóc người bệnh với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng chăm sóc người bệnh

- Điều dưỡng trưởng khoa cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình chăm sóc người bệnh của điều dưỡng

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Bộ Y Tế** (2001), Quản Lý Bệnh Viện, Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.

2. **Bộ Y Tế** (2004), "Điều dưỡng học và các nguyên lý cơ bản về điều dưỡng",Tài liệu quản lý điều dưỡng, Nhà Xuất bản Y Học, Hà Nội.

3. **Bộ Y Tế** (2004), " Mô hình phân công chăm sóc", Tài liệu quản lý điều dưỡng, Nhà Xuất bản Y Học, Hà Nội.

4. **Bộ Y tế** (2011), Thông tư 07/2011/TT – BYT ngày 26/1/2011 về hướng dẫn công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Hà Nội.

5. **Bộ Y tế** (2012), Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam Ban hành kèm theo quyết định số: 1352/QĐ – BYT ngày 21/4/2012 của Bộ Y tế,, Hà Nội.

6. **Trần Thị Hà Giang** (2011), Đánh gía sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh – Bệnh viện Da Liễu trung ương năm 2011, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

7. **Hội Điều dưỡng Việt Nam** (2010), " Chăm sóc điều dưỡng", Hướng dẫn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện, Hà Nội.

8. **Trương Thị Bích Ngọc** (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại một số khoa lâm sàng của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2011, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

9. **Nguyễn Thu** (2011), Đánh giá sự hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Điều dưỡng – phục hồi chức năng tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

10. **Phạm Anh Tuấn** (2011), Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại bệnh viện Việt Nam – Thụy điển Uông Bí năm 2011, Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

## Phụ Lục

## PHIẾU ĐIỀU TRA

# SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA NGOẠI TH - BVC

Mã số: ☐☐☐

## Phần 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỐI TƯỢNG

C.1.Tuổi: . . . . . .

C.2.Địa chỉ: . . . . . .

C.3.Giới tính: - Nam ☐

- Nữ ☐

C.4. Dân tộc: . . . . . .1.Kinh . . . ☐. . . . . 2. khác. . . . . .

C.5. Trình độ học vấn: - dưới hoặc bằngTiểu học

1. THCS ☐
2. PTCS ☐
3. PTTH ☐
4. Trung cấp ☐
5. Cao đẳng và đại học ☐
6. Trên đại học ☐

C.6.Nghề nghiệp: ☐

1. Học sinh,sinh viên
2. Nông dân ☐
3. Công nhân ☐
4. Cán bộ nhà nước ☐
5. Khác ☐

C.7. Số lần điều trị tại khoa này:

1. <= 1lần
2. > 2 lần

## Phần 2. NHẬN XÉT CỦA NB VỀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC CỦA ĐD

Sau đây là các thông tin về sự hài lòng của ông/bà với chế độ chăm sóc của điều dưỡng tại khoa Ngoại TH Bệnh viện C. Mỗi câu có 3 mức độ:

**1(Chưa tốt), 2 (Bình thường), 3 (Tốt)**

| TT | Sự hài lòng của Ông/bà với các chế độ chăm sóc của điều dưỡng trong các nội dung dưới đây | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sự hướng dẫn các thủ tục hành chính khi NB nhập khoa | | | |
| 2 | Sự chuẩn bị sắp xếp giường cho NB khi vào khoa | | | |
| 3 | Hướng dẫn nội quy khoa phòng và bệnh viện | | | |
| 4 | Hướng dẫn, hỗ trợ làm các XN | | | |
| 5 | Sự quan tâm, thăm hỏi tình trạng sức khỏe của NB | | | |
| 6 | Sẵn lòng giúp đỡ của điều dưỡng khi NB cần | | | |
| 7 | Động viên an ủi, khích lệ tinh thần NB | | | |
| 8 | Tôn trọng những bí mật riêng tư trong khi chăm sóc NB | | | |
| 9 | Kỹ năng thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc của điều dưỡng (Thay băng, tiêm thuốc, Đo mạch, nhiệt độ, HA…) | | | |
| 10 | Hướng dẫn của ĐD về chế độ dùng thuốc | | | |
| 11 | Tư vấn, hướng dẫn chế độ ăn theo bệnh lý | | | |
| | Theo dõi diến biến bệnh hàng ngày | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13** | Hỗ trợ động viên khuyến khích NB vận động để đề phòng biến chứng | | | |
| **14** | Hướng dẫn, hỗ trợ NB thực hiện vệ sinh cá nhân | | | |
| **15** | Giải thích cho NB trước khi thực hiện mỗi quy trình kỹ thuật chăm sóc | | | |
| **16** | Giải thích trước khi thực hiện thuốc và các XN cho NB | | | |
| **17** | Cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe cho NB | | | |
| **18** | Hướng dẫn NB cách tự chăm sóc khi nằm viện | | | |
| **19** | Hướng dẫn NB cách tự chăm sóc sức khỏe khi ra viện | | | |
| **20** | Vệ sinh khoa phòng (phòng bệnh, hành lang, nhà vệ sinh…) | | | |
| **21** | Vệ sinh các dụng cụ, phương tiện chăm sóc người bệnh | | | |
| **22** | Thái độ, giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận NB vào khoa | | | |
| **23** | Thái độ, giao tiếp của điều dưỡng trong khi chăm sóc BN | | | |
| **24** | Sự chuẩn bị, sắp xếp của ĐD khi người bệnh ra viện | | | |
| **25** | Mức độ hài lòng chung về chế độ chăm sóc của điều dưỡng trong thời gian nằm viện | | | |

Ý kiến của ông/bà là cơ sở để khoa chúng tôi phát huy những điểm tốt , sửa chữa những điều chưa tốt, cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người bệnh tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn ông bà.

Sông công, ngày  tháng  năm 2017

**ĐIỀU TRA VIÊN**